

1. INFORMACIÓN DEL REPORTANTE				
Fecha de notificación	Origen del reporte		Nombre de la Institución donde ocurrió el evento	Código PNF
	Departamento – Municipio			
2023-05-04	SUCRE - SINCELEJO		INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE	
Nombre del Reportante primario	Nombre del Paciente o Acudiente	Consecutivo	Profesión del reportante primario	
Ana Yeimi Sanchez Lozano	PACIENTE	ctPCi4jo	ENFERMERA	
Correo electrónico institucional del reportante primario				
asanchez@encontactopeoplemarketing.com				

2. INFORMACIÓN DEL PACIENTE						
Fecha de nacimiento del paciente	Edad del paciente en el momento del EA	Documento de identificación del paciente	Iniciales del paciente	Sexo	Peso	Talla
	Edad – Años/Meses/ días	CC TI RC NUIP Cód. Lab Otro S/I		M F S/I	(Kg)	(cm)
1959-12-23	63	C.C - 92504354	EDCVA	M	97	178
Diagnóstico principal y otros diagnósticos:						
CARCINOMA DE CELULAS RENALES						
HIPERTENSION						
DIABETES NO INSULINOREQUIRIENTE						
ENFERMEDAD CEREBRAL ISQUEMICA						
PARESTESIA SECUNDARIA						



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL		VIGILANCIA	
FORMATO REPORTE DE SOSPECHA DE EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS - FOREAM			
Código: IVC-VIG-FM026	Versión: 01	Fecha de Emisión: 05/04/2016	Página 1 de 3

3. INFORMACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS								
Registre todos los medicamentos utilizados y marque con una “S” el (los) sospechoso(s), con una “C” el (los) concomitantes y con una “I” las interacciones.								
S/C/I	Medicamento (Denominación Común Internacional o Nombre genérico)	Indicación	Dosis	Unidad de medida	Vía de administración	Frecuencia de administración	Fecha de inicio	Fecha de finalización
S	CABOZANTINIB	CARCINOMA DE CELULAS RENALES	60	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	20/04/2023	24/04/2023
S	CABOZANTINIB	CARCINOMA DE CELULAS RENALES	60	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	29/04/2023	ACTUALMENTE
C	LINAGLIPTINA	DIABETES	2,5	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	METFORMINA	DIABETES	850	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	IRBESARTAN	HIPERTENSION	300	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	AMLODIPINO	HIPERTENSION	10	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	CARBONATO DE CALCIO	DEFICIENCIA DE CALCIO	600	MG	ORAL	CADA 24 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
C	VITAMINA D	DEFICIENCIA DE VITAMINA D	200	UI	ORAL	CADA 24 ORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
S	DENOSUMAD	CARCINOMA DE CELULAS	120	MG	SUBCUTANEO	CADA 28 DIAS	19/04/2023	ACTUALMENTE
C	PARACETAMOL	MANEJO DEL DOLO	1	GR	ORAL	CADA 8 HORAS	SIN INFORMACION	ACTUALMENTE
Información comercial del medicamento sospechoso								
Titular del Registro sanitario			Nombre Comercial		Registro sanitario		Lote	
			CABOMETIX		SIN INFORMACION		SIN INFORMACION	

4. INFORMACIÓN DEL EVENTO ADVERSO

Fecha de Inicio del Evento Adverso: 2023-04-19

Descripción y análisis del Evento Adverso:

PACIENTE FUE HOSPITALIZADO POR REPORTE ANTECEDENTE MEDICO DE DE ESTUDIO PET-CT QUE REVELARON AREAS ANOMALAS DE HIPERMETABOLISMO GLICOLICO EN: LA GLANDULA PAROTIDA IZQUIERDA, EL CUELLO, EL MEDIASTINO EN TOPOGRAFIA DEL HILO PULMONAR DERECHO, EL ABDOMEN LESION OCUPATIVA CON DENSIDAD DE TEJIDOS BLANDOS, SISTEMA ESQUELETICO EN PROYECCION DE LA PORCION LATERAL DEL 7 ARCO COSTAL DERECHO, LA PIEL EN LA PARED LATERAL DERECHA DEL ABDOMEN. LA ANTERIOR EVIDENCIA SUGIRIO HOSPITALIZACION DEL PACIENTE PARA TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO, DE QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA. PACIENTE QUE SE ENCONTRABA HOSPITALIZADO DESDE EL 19 DE ABRIL POR PRESENTAR DOLOR LUMBAR, INESTABILIDAD DE LA MARCHA Y PERSISTENCIA DE LA ENFERMEDAD. ESTANDO HOSPITALIZADO REALIZARON QUIMIOTERAPIA DE DENOSIMAD EL 19/04/2023 INICIARON TOMA DE CABOZANTINIB EL 20/04/2023 HASTA EL 24/04/2023. LE FUE SUSPENDIDO POR ORDEN MEDICA POR INICIO DE RADIOTERAPIAS AL INGRESO DEL PROGRAMA EL DIA DE AYER Y AL INDAGAR SOBRE LA EVOLUCION DE LA HOSPITALIZACION REFIEREN QUE LE DIERON EGRESO EL 29/04/2023 Y ESE MISMO DIA REINICIO LA TERAPIA CON CABOZANTINIB. REFIERE AL MOMENTO CON DIFICULTAD PARA CER DEL CUERPO.

Evento adverso:

INICIO TERAPIA CABOZANTINIB EN HOSPITALIZACION, SUSPENCION TEMPORAL DEL TRATAMIENTO CABOZANTINIB, INCIO QUIMIOTERAPIA DENOSUMAB, RADIOTERAPIA Y REINICIO TRATAMIENTO CABOZAMTINID, DIFICULTAD PARA HACER DEL CUERPO

Desenlace del evento (Marcar con una X)

Recuperado / Resuelto sin secuelas

Recuperado / Resuelto con secuelas

X Recuperando / Resolviendo

No recuperado / No resuelto

Fatal

Desconocido

Seriedad (Marcar con X)

Produjo o prolongó hospitalización

Anomalía congénita

Amenaza de vida

Muerte (Fecha: _____)

Produjo discapacidad o incapacidad permanente / condición médica importante

Ninguno

	Si	No	No sabe
¿El evento se presentó después de administrar el medicamento?	X		
¿Existen otros factores que puedan explicar el evento (medicamento, patologías, etc.)?	X		
¿El evento desapareció al disminuir o suspender el medicamento sospechoso?			X
¿El paciente ya había presentado la misma reacción al medicamento sospechoso?			X
¿Se puede ampliar la información del paciente relacionando con el evento?	X		